

LA GROSSESSE EXTRA UTERINE

I. Objectifs

- ✓ Comment poser le diagnostic
- ✓ Assurer le traitement adéquat
- ✓ Préserver la fertilité
- ✓ Traitement

II. Introduction

- La GEU ou nidation ectopique est l'implantation ou l'évolution de l'œuf en dehors de la cavité utérine
- 2% des grossesses : nette croissance
- En augmentation MST et leurs séquelles Tubaires
- Le pronostic vital est mis en jeu
- **Le Diagnostic** doit être précoce mais parfois difficile
- **Le Traitement** sera plus conservateur d'autant que le diagnostic est précoce

QE!!

III. Physiopathologie

- Cette fécondation s'effectue généralement dans la portion distale de la trompe utérine
- L'embryon ainsi formé, migre dans la trompe vers la cavité utérine
- Il s'implante dans le fond utérin 6 Jrs après la fécondation
- L'implantation en dehors de la cavité utérine → GEU
 - Le plus souvent liée à une anomalie de la perméabilité des trompes
 - Une anomalie de leur mobilité
- Donc tout processus, qui retarde la migration embryonnaire augmente le risque de GEU
- En cas de migration :
 - la migration de l'œuf s'arrête trop tard

- l'embryon s'implante en dehors de la cavité utérine
- Différents endroits :

- Grossesse ampullaire +++75%
- Grossesse isthmique 20%
- Grossesse ovarienne 1%
- Grossesse cervicale
- Grossesse interstitielle 3%
- Autres : abdomen, diverticule adénomyose, grossesse cornuée...

QE!!

IV. Facteurs de risque

- Les IST, salpingites ou les endométrites 6X plus fréquentes, la Chlamydiae trachomatis la + fréquente
- Les ATCD de chirurgie tubaire ou pelvienne appendicectomie par exemple
- Toutes les autres causes d'altération de la paroi Tubaire endométriose, tuberculose...
- Tabac relation dose-effet
- Le dispositif intra-utérin
- La fécondation in vitro, transfert embryons

- Fréquemment interstitielles
- 4,5% après FIV
- Grossesse hétérotopique

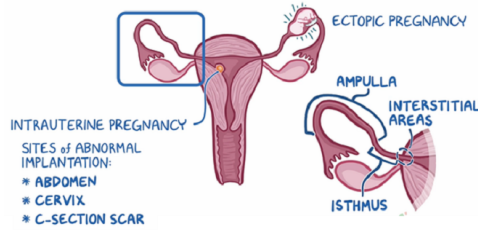
- Certains médicaments pilules microprogestatives, les inducteurs de l'ovulation
- L'âge maternel élevé
- Aucun facteur détecté

V. Evolution

- Evolution brutale et progressive :
 - Vers la rupture de l'organe portant la grossesse

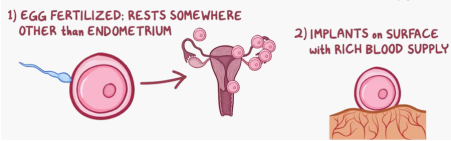
ECTOPIC PREGNANCY

PREGNANCY that DEVELOPS OUTSIDE of UTERINE CAVITY



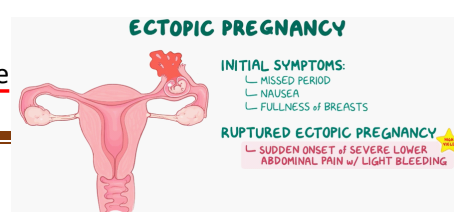
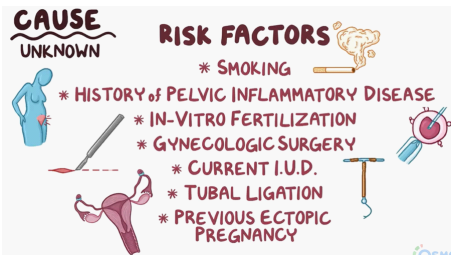
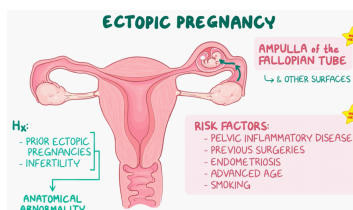
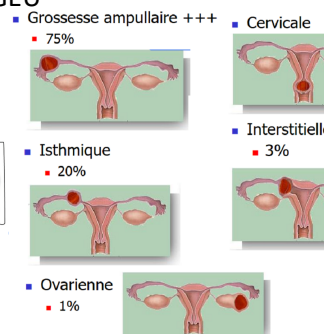
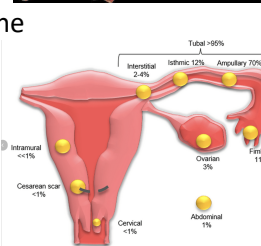
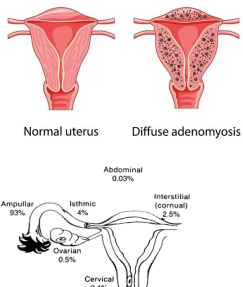
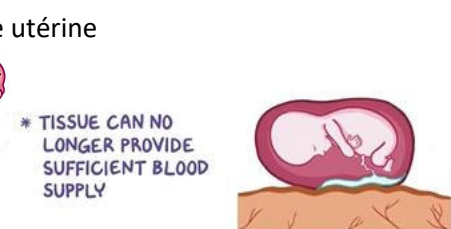
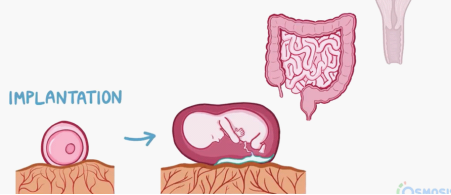
ECTOPIC PREGNANCY

"OUT OF PLACE" SOMEWHERE OTHER THAN THE UTERINE CAVITY



ECTOPIC PREGNANCY

VARIOUS SURFACES INCLUDING :



- Souvent trompe utérine, mais aussi une corne utérine, un ovaire, le col
- Hémorragie interne
- Installation d'un état de choc mortel si absence de traitement.
- Avortement tubo-péritonéal : dans la cavité péritonéale
 - Soit elle se résorbe progressivement
 - Soit elle s'en kyste progressivement (hématocèle enkysté)
 - Souvent se greffe sur un organe de voisinage et évolue.



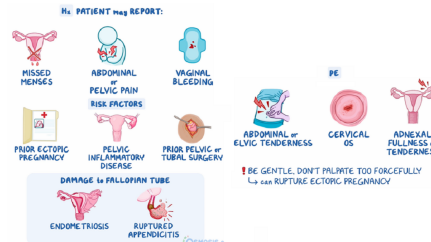
QE!!

VI. Diagnostic positif :

Type de description : GEU tubaire non compliquée

- Le diagnostic se base sur :

- Clinique :
 - Interrogatoire
 - Examen physique
- Paraclinique :
 - Biologie
 - Radiologie
 - Coelioscopie



- Aucun Symptôme n'est spécifique d'une GEU
- L'existence de FDR de GEU augmente la probabilité de GEU
- Certains signes peuvent parfois manquer au tableau clinique global
- Chaque signe a une valeur probante

1. Interrogatoire :

- ❖ Age
- ❖ Gestes et parités : particularités
- ❖ ATCD, prise de contraceptifs
- ❖ Un retard de régies,
- ❖ signes sympathiques
- ❖ Métrorragies peu abondantes de couleur sépie
- ❖ Douleur pelvienne sus-pubienne unilatérale d'intensité variable, parfois irradiant à l'épaule, d'apparition progressive ou brutale voire en coup de poignard
- ❖ Malaise voire vertiges, lipothymies qui sont des signes de gravité
- ❖ Absence de retard des règles, mais les règles sont abondantes inhabituellement ou d'aspect inhabituel.

2. Examen clinique : très variable

Pratiqué dans de bonnes conditions, vessie, rechute vide sur une patiente détendue

- Pouls, tension artérielle, conjonctives
- L'abdomen est souple, la palpation profonde hypogastrique réveille d'une douleur ou l'accentue
- Au speculum :
 - Le col est gravité, ferme, sans glaire
 - Le sang endo-utérin
- Au toucher vaginal :
 - L'utérus est un peu augmenté de volume mais moins que le voudrait l'âge de la grossesse
 - Parfois masse annexielle mal limitée très sensible
 - Sensibilité latéro-utérine sans masse
 - Parfois la mobilisation utérine est douloureuse
 - Une douleur au niveau du cul de sac de Douglas témoignant d'une irritation péritonéale

3. Paraclinique : Deux examens orientent +/- fortement le diagnostic de la GEU d'autant + lorsqu'ils sont confrontés :

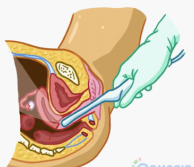
- Beta HCG
- L'échographie pelvienne
 - a. Dosage plasmatique de Béta HCG
- Spécificité et sensibilité bonnes
- Existence de tissus trophoblastiques
- En aucun cas différencier une GIU d'une GEU

ECTOPIC PREGNANCY

HEMODYNAMICALLY UNSTABLE	HEMODYNAMICALLY STABLE
IMMEDIATE SURGERY	SERIAL MEASUREMENTS OF hCG NORMAL: hCG x 2 every 48 HRS DOES NOT OCCUR → ECTOPIC PREGNANCY
	TRANSVAGINAL ULTRASOUND → WEEK 5-6 CURETTAGE or SCRAPING CHANGES IN ENDOMETRIUM NO EMBRYONIC or TROPHOBLASTIC TISSUE

DIAGNOSIS

- VARIES BASED ON HEALTH
- HEMODYNAMICALLY STABLE (vital signs normal)
 - NO HYPOTENSION or TACHYCARDIA
 - SERIAL HCG TESTING
LEVELS DOUBLING every 2 DAYS
Typical in early pregnancy
- TRANSVAGINAL ULTRASOUND
 - INTRAUTERINE PREGNANCY (visible by week 5-6)
 - EXCESS FLUID



Conclusion clinique

QE!!

2. Formes symptomatiques trompeuses :

- Pseudo-abortives : Métorrhagies sang rouge, col ouvert, élimination d'une caduque
 - **Diagnostic redressé par cinétique Béta HCG**
 - **Voire coelioscopie devant la persistance de la douleur**
- Fébriles 38°-39°C, Accélération de la VS, Hyperleucocytose, Beta HCG
- Pauci-symptomatiques
- Association GEU GIU

QE!!

IX. Traitement

1. Objectifs:

- ✓ Traiter la GEU avant l'hémo-péritoine
- ✓ Préserver la fertilité
- ✓ Limiter le risque de récurrence
- ✓ Limiter la morbidité thérapeutique

2. Moyens thérapeutiques:

a. Traitement chirurgical :

- Coelioscopie ou laparotomie :

- Chirurgie radicale : Salpingectomie
- Chirurgie conservatrice : Salpingotomie avec aspiration du produit de conception
- Expression sur la trompe permettant l'expulsion en dehors

b. Traitement médical:

- La méthotrexate (1mg/Kg) (le + utilisé) :

- Un antinéoplasique cytostatique de type anti-folinique inhibant la synthèse des Acides nucléiques au sein des cellules, par voie IM ou locale per coelioscopique ou sous contrôle échographique

c. Abstention thérapeutique

3. Indications:

a. Abstention thérapeutique :

- GEU asymptomatique
- L'hémodynamique et l'hématocrite stable
- Béta HCG initiale < 1000UI/l
- Absence échographique d'hémopéritoine et du sac ovulaire
- Surveillance médicale très rapprochée, rigoureuse
- Dosage actif de Béta HCG et d'hématocrite
- Répétition d'examens échographiques

↳ Les patients doivent être informés du risque d'échec

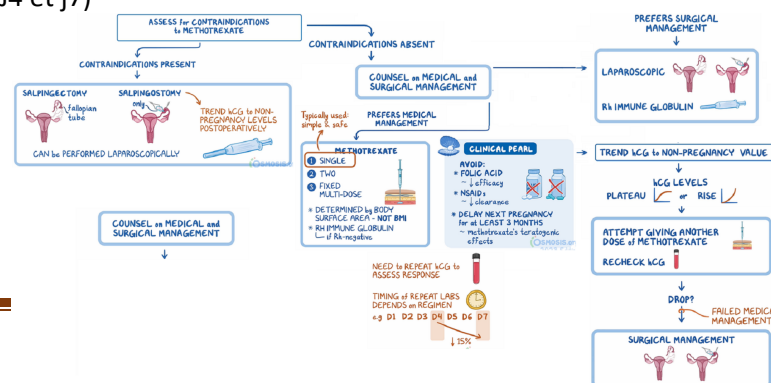
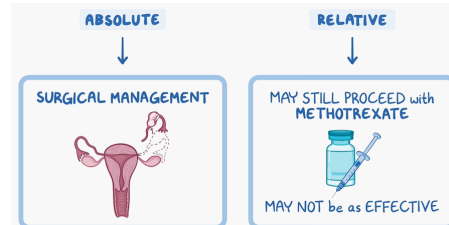
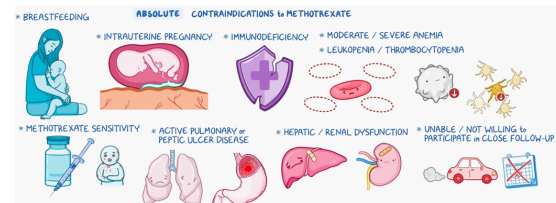
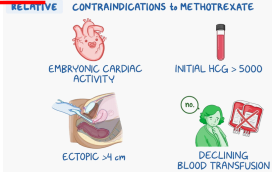
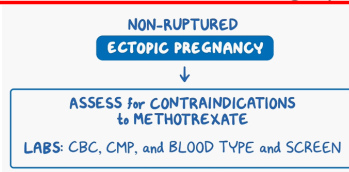
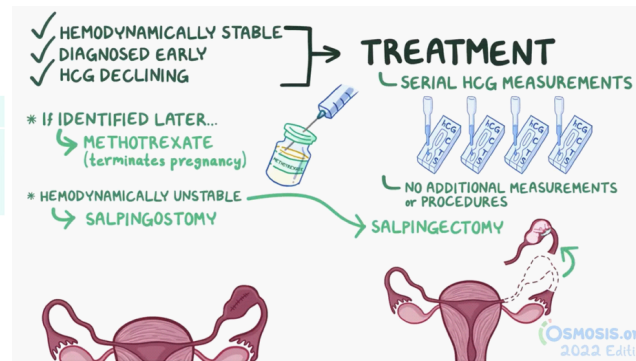
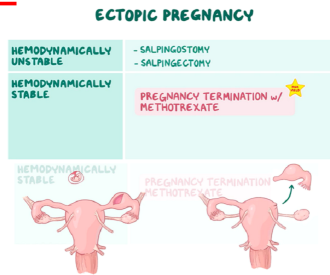
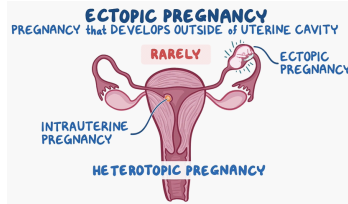
b. Traitement médical

- GEU pauci-symptomatique
- Béta HCG < 1000 UI/l
- Hématosalpinx taille 3 cm, pas d'hémopéritoine
- Le dosage des Béta HCG devrait être surveillé jusqu'à négativation
- Augmentation fréquente des douleurs pelviennes entre le 1er et le 4ème Jr suivant l'injection élévation transitoire de Béta HCG pouvant survenir à J2 de l'utilisation des méthotrexate
- Réussite si diminution des Béta HCG de 15% (entre J4 et J7)
- Le taux d'échec est d'environ 10 à 20%
- Parfois nécessité d'une 2ème injection

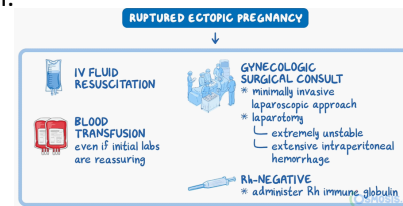
c. Traitement chirurgical

- Préférence par coelioscopie :
 - Conservateur si possible
 - GEU non compliquée.

Remarque



- Surveillance des taux de Béta HCG en post-op a 48h pour éliminer toute persistance de trophoblaste actif, son monitoring sera conseillé jusqu'à négativation.
- Radical**
 - Masse >5 à 6 cm
 - Altération importante de la Trompe
 - Récidive de la grossesse tubaire du même côté
 - Importante hémorragie interne
 - Le contrôle de l'hémostase est impératif après une tentative d'un traitement chirurgical conservateur

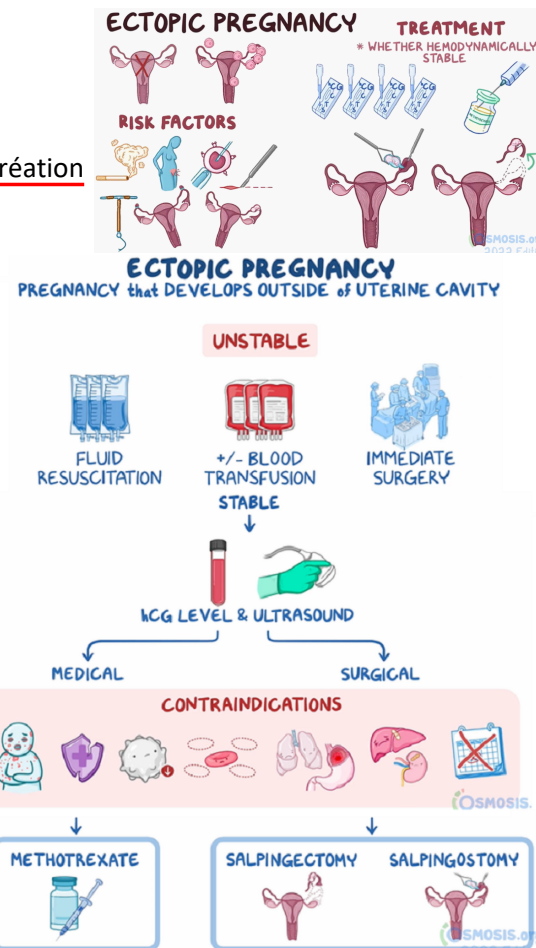


X. Pronostic

- La fertilité après traitement de la GEU :
 - Après traitement chirurgical radical : taux de GIU obtenu à 50%, 15% de GEU controlatérale
 - Après traitement conservateur aux de GIU atteint 60 %
- Le risque de récurrence dépend également des ATCD de la patiente
- Nécessité de consulter dès le début d'une nouvelle grossesse**

XI. A retenir

- GEU** : Première cause de mortalité maternelle au premier trimestre
- Diagnostic doit être évoqué de principe devant :**
 - Douleurs associées à des métrorragies → femme en âge de procréation
- Diagnostic repose sur le trépied :**
 - Clinique, écho et dosage des Béta HCG
 - Parfois cœlioscopie
- Le **traitement** est souvent **chirurgical par cœlioscopie conservateur**
- Formes précoces : traitement par **méthotrexate**
- Il ne faut pas oublier :**
 - Les formes cataclysmiques de GEU → Urgence
 - Prévention contre l'allo-immunisation rhésus



Cas clinique

Madame X âgée de 36 ans G2P2 avec 2 enfants vivants consulte pour des métrorragies

G2P2 : 2 grossesse quel que soit l'aboutissement / 2 grossesses menées à terme pouvant être vivants ou non

Métrorragies : saignement utérin anormal en dehors des menstruations

Que faut-il chercher chez cette patiente à l'interrogatoire ?

- Demander la DDR car ici on est devant deux grands tiroirs :

Présence de grossesse :

DDR = l'aménorrhée se chiffre en semaines ☐ on dit métrorragie sur aménorrhée de X semaines, 3 pathologies peuvent mettre en jeu au cours du **premier trimestre** le pc vital et fonctionnel (fertilité) de la patiente :

- GEU
- Maladie trophoblastique gestationnelle
- Les avortements

2^{ème} et 3^{ème} trimestre :

- Placenta prævia
- Hématome rétro-péritonéale (complication propre de la pré-éclampsie)
- La rupture utérine

Pas de grossesse

Le chef de fil c'est le cancer du col utérin

- Chercher les caractéristiques de ces métrorragies : l'abondance, la couleur, spontanée ou provoquée, les signes accompagnateurs : fièvre, douleurs pelviennes...